Pathologies des glandes annexes - foie, voies biliaires, pancréas

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : ALAT, ASAT = transaminases · PAL = phosphatases alcalines · GGT = gamma-glutamyl-transférase · TP = taux de prothrombine · INR = rapport normalisé international · N = normale · VHA… VHE = virus des hépatites · MASLD = stéatose hépatique associée à un dysfonctionnement métabolique · HTP = hypertension portale · CHC = carcinome hépatocellulaire · DPC = duodénopancréatectomie céphalique · TCM = triglycérides à chaîne moyenne · → = donne · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : transaminases = **lésion** (cytolyse), pas fonction · fonction = **TP, facteur V, albumine** · cholestase = **PAL + GGT + bilirubine conjuguée** · cirrhose : **35 kcal/kg/j**, **1,2-1,5 g protéines/kg/j**, **collation du soir**, **jamais de restriction protéique** · pancréatite chronique : **pas de régime pauvre en graisses**, extraits **au début du repas** · zéro alcool.

1. Lire un bilan hépatique et pancréatique (33.3)

Syndrome	Marqueurs	Conséquence diététique
Cytolyse	ALAT, ASAT ↑ (ALAT plus spécifiques du foie)	arrêt alcool et produits toxiques pour le foie ; alimentation normale
Cholestase	PAL, GGT ↑, bilirubine conjuguée ↑	malabsorption des graisses et des vitamines A, D, E, K ; TCM si besoin
Insuffisance hépatocellulaire	TP, facteur V, albumine ↓ ; bilirubine ↑	protéines élevées, collation du soir
HTP	plaquettes ↓, ascite, varices	sel modéré ; textures tendres si varices
Pancréas exocrine	lipase > 3 N (aigu) ; élastase fécale ↓ (chronique)	extraits pancréatiques

- **Ictère** : bilirubine > 17 µmol/L (visible au-delà de 35-50) · **libre** (hémolyse, maladie de Gilbert) ≠ **conjuguée** (cholestase : **urines foncées, selles décolorées**, prurit).

2. Hépatites virales (33.3.1)

- **A et E** : transmission **féco-orale** (eau, aliments ; E = zoonose du porc en France) · **pas de chronicité** (sauf E chez l'immunodéprimé) · vaccin contre A.
- **B, C, D** : sang, voie sexuelle, mère-enfant · **B** : chronicité surtout chez le nouveau-né, **vaccin** · **C** : souvent chronique, **pas de vaccin** mais guérison > 95 % par antiviraux · **D** : seulement avec le B.
- Risque commun des formes chroniques : **cirrhose** puis **CHC**.

3. Lithiase biliaire (33.3.1)

- Calculs surtout **cholestéroliques** (bile sursaturée) · facteurs : femme, âge, obésité, **amaigrissement rapide**, grossesse.
- Lithiase **asymptomatique** : ni opération ni régime · **colique hépatique** (douleur sans fièvre) · **cholécystite** (douleur + fièvre) · **angiocholite** (douleur → fièvre → ictère) · pancréatite biliaire.
- Traitement de la lithiase symptomatique : **cholécystectomie** · après : **pas de régime** (la bile continue de couler du foie vers le duodénum).

4. Pancréatites et cancer du pancréas (33.3.1-2)

- **Pancréatite aiguë** : causes principales **lithiase biliaire** et **alcool** · activation de la trypsine dans le pancréas · diagnostic = **2 critères sur 3** (douleur, lipase > 3 N, imagerie) · gravité = **défaillances d'organes** (pas le taux de lipase).
- Nutrition : **reprise orale précoce** · forme grave : **entérale dans les 24-72 h** (moins d'infections que la parentérale) · parentérale en dernier recours.
- **Pancréatite chronique** (alcool + tabac) : douleur, calcifications, **insuffisance exocrine** (stéatorrhée, carence en vitamines A, D, E, K) et **diabète de type 3c** (insuline et glucagon ↓ → hypoglycémies) · 30-35 kcal/kg/j · **pas de restriction des graisses** · extraits pancréatiques à chaque repas, **au début**.
- **Cancer du pancréas** : pronostic sombre · tête → **ictère indolore + grosse vésicule** · dénutrition fréquente · minorité opérable.

5. Stéatose, cirrhose et cancer du foie (33.3.2-3)

- **Stéatose** = triglycérides dans ≥ 5 % des hépatocytes · **MASLD** = stéatose + au moins 1 critère cardiométabolique, sans alcool excessif · évolution possible : stéatohépatite → fibrose → cirrhose.
- Prise en charge MASLD : **perte de poids 7-10 %**, suppression des **boissons sucrées**, activité physique 150-300 min/semaine.
- **Cirrhose** = fibrose diffuse + **nodules de régénération** → insuffisance hépatocellulaire + **HTP** (varices œsophagiennes, splénomégalie, ascite) · complications : hémorragie, ascite infectée, **encéphalopathie**, CHC · gravité : score de **Child-Pugh A, B, C** (bilirubine, albumine, TP, ascite, encéphalopathie).
- **Ascite** : HTP + vasodilatation + rétention rénale de sodium (aldostérone), pas seulement l'albumine basse.
- **CHC** : survient surtout sur cirrhose → échographie de surveillance **tous les 6 mois**.

6. Nutrition du cirrhotique et chirurgie (33.3.3-4)

- Évaluer sur le **poids sec** (l'ascite masque la perte musculaire) · **35 kcal/kg/j** · protéines **1,2-1,5 g/kg/j**, **même en cas d'encéphalopathie** (on traite les facteurs déclenchants et la constipation).
- **3 repas + 2-3 collations**, dont une **collation du soir** (limite le jeûne nocturne et la fonte musculaire).
- Ascite : sel **modéré** (sodium 80-120 mmol/j) · **pas de restriction hydrique** sauf natrémie < 125 mmol/L · **zéro alcool** · hépatite alcoolique : **thiamine** avant tout apport

de glucose.
- Chirurgie : **DPC (Whipple)** → insuffisance exocrine, diabète possible, carences en fer et calcium · pancréatectomie totale → diabète instable + extraits à vie · **splénectomie** → vaccins · **transplantation** : immunosuppresseurs (éviter **pamplemousse** et millepertuis), hygiène alimentaire, prévenir le syndrome métabolique.

Pièges

- Transaminases ↑ = **lésion**, pas baisse de fonction.
- Hépatite A : **jamais chronique** · hépatite C : **pas de vaccin**.
- Lithiase découverte par hasard : **pas d'opération ni de régime** · après cholécystectomie, la bile **est toujours produite**.
- Lipase ≠ gravité · pancréatite grave : **entérale** plutôt que parentérale.
- Extraits pancréatiques **au début** du repas · ictère du cancer de la tête = **indolore**.
- Cirrhose : **pas de restriction hydrique** systématique ni de **restriction protéique**.